



Perioperative nursing care in Plastic surgery : Palatoplasty

By....

Miss Auchuta Ruangwinyuwetch

หัวข้อเรื่อง

- ▶ แนะนำสถานที่ภายในห้องผ่าตัด
- ▶ วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด
- ▶ ประเภทของการผ่าตัด
- ▶ ตัวอย่างการผ่าตัดพื้นฐาน(ที่พบบ่อย)ของหน่วยผ่าตัด ศัลยศาสตร์ตกแต่งที่ควรทราบ ได้แก่ Palatoplasty
- ▶ สรุปประเด็นสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะปากแหว่งใน ระยะผ่าตัด
- ▶ ช่วงซักถาม

แนะนำสถานที่

หน่วยผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ มีจำนวนห้องผ่าตัด 3 ห้อง แบ่งเป็น

- ห้องสำหรับการผ่าตัดด้วยวิธีการดมยาสลบ (GA)

จำนวน 2 ห้อง

- ห้องสำหรับการผ่าตัดด้วยวิธีการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ (LA) จำนวน 1 ห้อง

- ห้องสำหรับเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและติดตามผลหลังผ่าตัด (ห้องF/U) จำนวน 1 ห้อง

มีผู้เข้ารับบริการ 10-15รายต่อวัน 200-220รายต่อเดือน

แนะนำสถานที่

▶ ห้องผ่าตัด



แนะนำสถานที่

- ▶ ห้องติดตามผลหลังผ่าตัด(F/U)



วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสำคัญ คือ

- เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาตั้งแต่กำเนิด
- เพื่อแก้ไขพยาธิสภาพ
- เพื่อแก้ไข/รักษาอาการบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุ
- เพื่อตกแต่งเสริมความงาม

วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด

- **Congenital disorders**

Example: - cleft lip

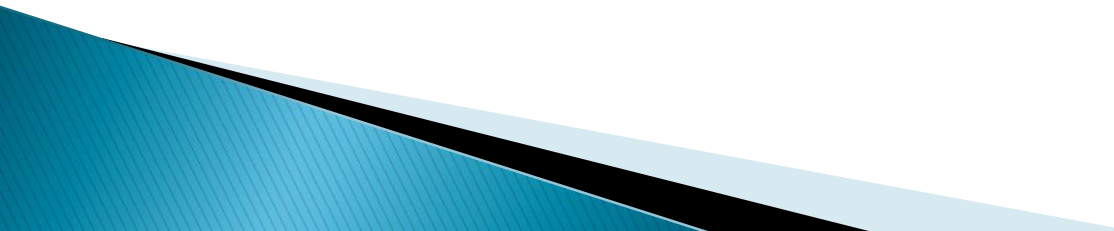
- cleft palate

- syndactyly

- polydactyly

- FEEM

etc.



วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด

- Pathology

Example: - Tumor

- CA floor of mouth

etc.

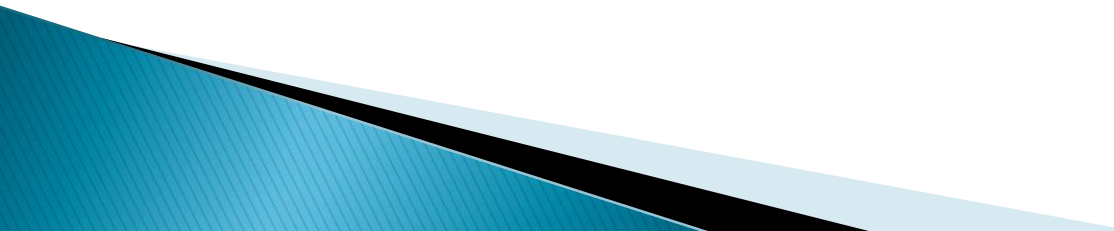
วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด

- Accident cases

Example: - Burn (from scald, chemical etc.)

- Hand injury (example : amputation of digits,
fracture of the hand, tendon injuries of hand etc.)

etc.



วัตถุประสงค์ของการผ่าตัด

- Cosmetic

Example: - Blepharoplasty

- Rhinoplasty
- Lipofilling / Liposuction
- Laser
- Augment mammoplasty
- etc.

ประเภทของการผ่าตัด

ประเภท/กลุ่มหัตถการสำคัญ แบ่งได้ดังนี้

- Correction / Reconstruction** : Cheiloplasty, Palatoplasty*
- Microsurgery** : Fibular free flap / ALT free flap
- Hand surgery** : Repair flexor tendon / radial artery (ต่อนิ้ว) ,K-wire fixation
- Debridement & Skin graft** : STSG , FTSG
- Cosmetic surgery** : Blepharoplasty , Rhinoplasty , Augmented Mammoplasty , Laser

ประเภทของการผ่าตัด

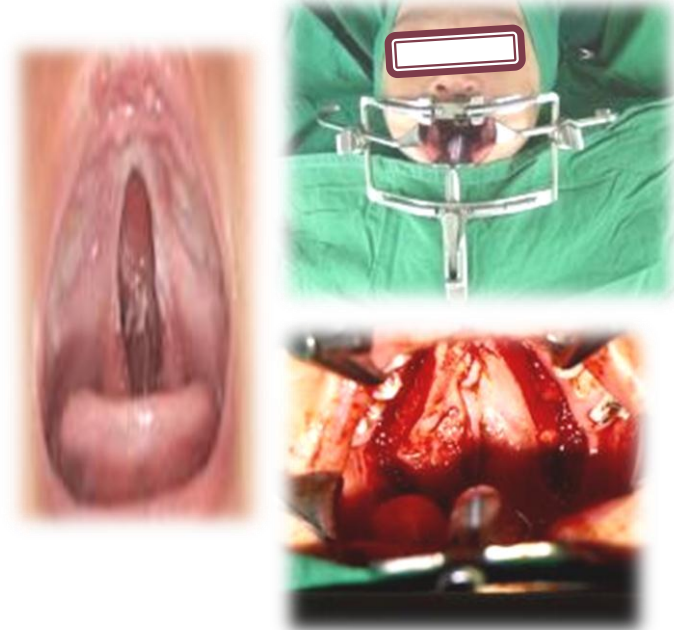
1. Correction / Reconstruction

Example: Cheiloplasty



อ้างอิง : <https://th.theasianparent.com/2019-cleft-lip-and-cleft-palate-1709>

Palatoplasty*



ประเภทของการผ่าตัด

1. Correction / Reconstruction

Example: MOCUT



อ้างอิง : http://www.craniofacial.or.th/kn_feem.php

ประเภทของการผ่าตัด

2. Microsurgery Example: FFF / ALT Free Flap



ประเภทของการผ่าตัด

3.Hand surgery Example: Repair flexor tendon / radial artery (ต่อเนื่อง)



ประเภทของการผ่าตัด

3.Hand surgery Example: K-wire fixation



ประเภทของการผ่าตัด

4. Debridement & Skin graft



ประเภทของการผ่าตัด

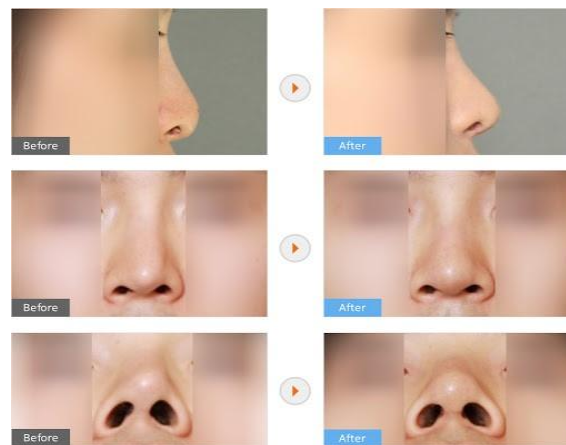
5.Cosmetic Example: Blepharoplasty



อ้างอิง : <https://thaihealthlife.com>

ประเภทของการผ่าตัด

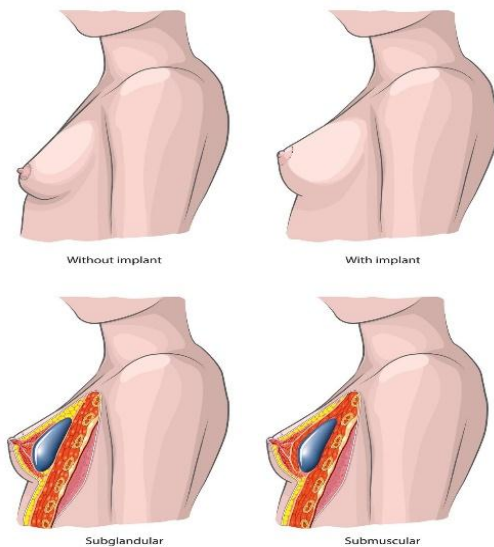
5.Cosmetic Example: Rhinoplasty



อ้างอิง : <http://graceclinic.co.kr/th/>

ประเภทของการผ่าตัด

5.Cosmetics Example: Augmented Mammoplasty



อ้างอิง : <http://www.doctorsaran.com/service-breast.php>

ประเภทของการผ่าตัด

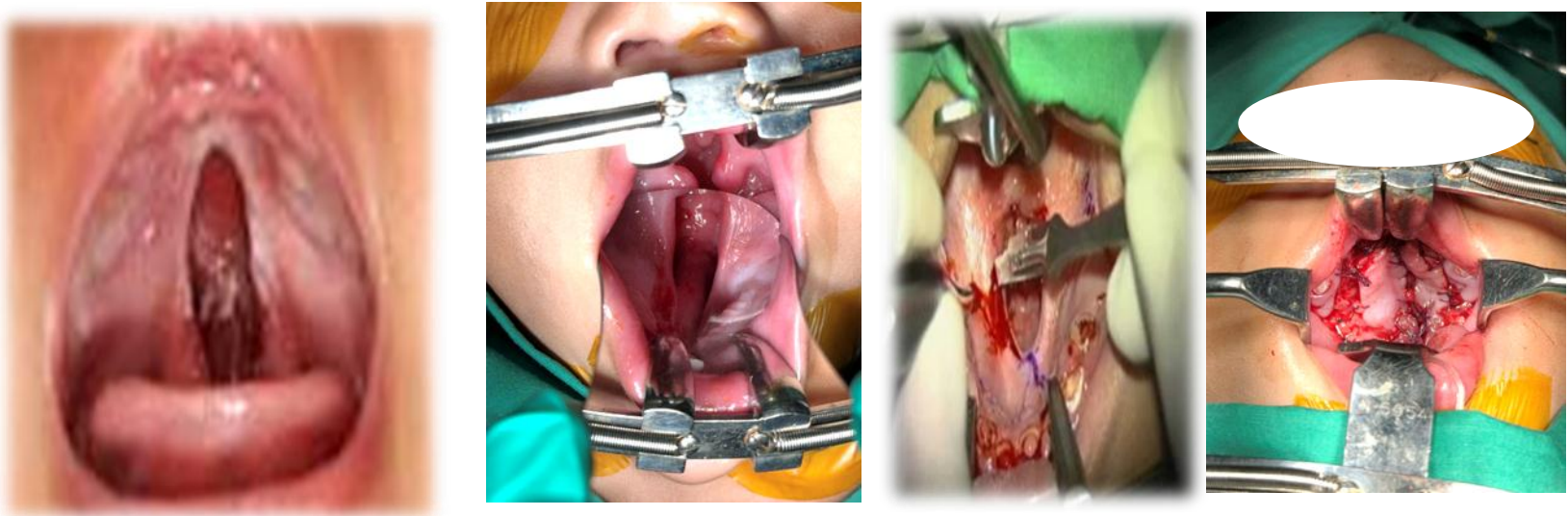
5.Cosmetics Example: Laser



อ้างอิง : <https://www.pobpad.com>

การผ่าตัดพื้นฐานที่ควรทราบ

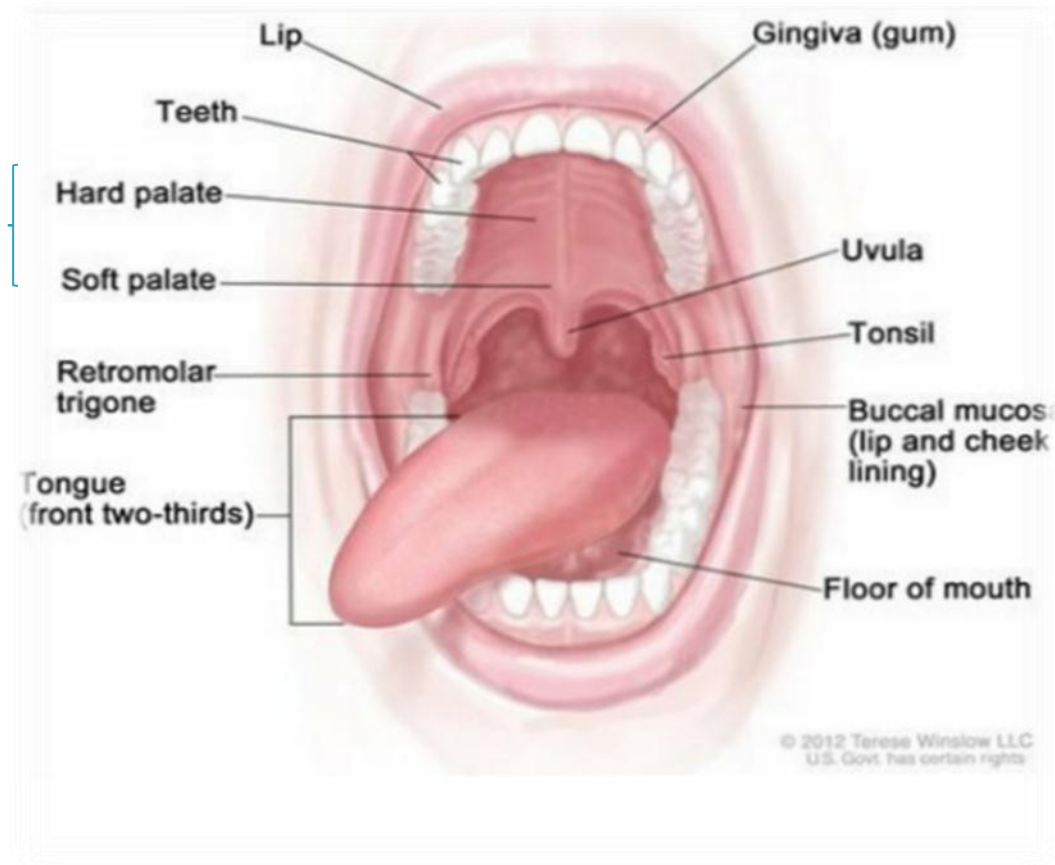
การผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดานโหว่ (Cleft Palate)



พัฒนาการ (Embryology)

- ▶ การเจริญเติบโตของใบหน้า ปาก และเพดานของทารก เกิดขึ้นเมื่อมีอายุในครรภ์ของมารดา ระหว่าง 4-8 สัปดาห์
- ▶ เจริญเติบโตต่อเนื่องเป็นส่วนต่างๆ ที่สมบูรณ์ เมื่อมีอายุในครรภ์มารดา 12 สัปดาห์

Anatomy ของเพดานปากปกติ



อ้างอิง : <http://www.scimath.org/lesson-biology/item/7044-2017-05-22-15-19-05>

Anatomy ของเพดานปากปกติ

▶ เพดานปาก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนด้านหน้า เป็นส่วนที่มีกระดูก เรียกว่า เพดานแข็ง (hard palate)
2. ส่วนด้านหลังในช่องลำคอ มีลักษณะอ่อนนุ่ม ไม่มีกระดูก เรียกว่า เพดานอ่อน (soft palate)

หน้าที่ของเพดานปาก

▶ เพดานปาก มีหน้าที่ต่างๆดังนี้

- 1.ช่วยคงรูปร่างของช่องปาก
- 2.แยกช่องปากออกจากช่องจมูก
- 3.เป็นทางผ่านของอาหาร
- 4.ช่วยในการออกเสียง
- 5.ช่วยในการหายใจ
- 6.ต่อมต่างๆที่เยื่อบุผิวจะช่วยสร้างน้ำลายและรับรสชาติอาหาร

มาทำความรู้จักกับภาวะเพดานโหว่กันเถอะ

▶ ภาวะเพดานโหว่ (cleft palate)



อ้างอิง : <http://kkucleft.kku.ac.th/cleftonline/>

▶ ภาวะเพดานโหว่ (cleft palate) :

- เป็นความผิดปกติแต่กำเนิด ไม่ใช่โรคติดต่อ
- พบรอยแยกบริเวณเพดานปาก
- มักพบร่วมกับความผิดปกติอื่น เช่น ภาวะปากแหว่ง
ความผิดปกติทางการได้ยิน เป็นต้น

ชนิดของเพดานโหว่

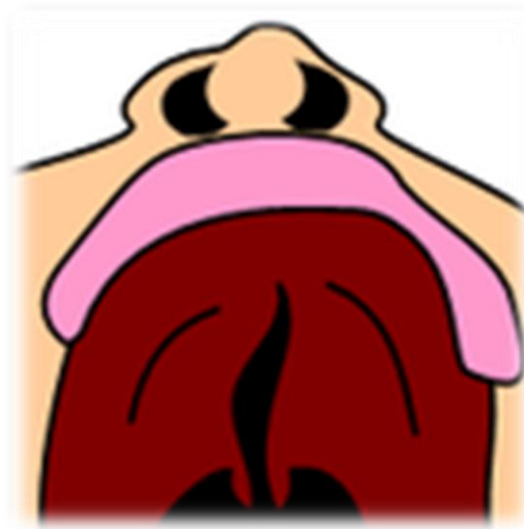
▶ เพดานโหว่ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เพดานโหว่ชนิดสมบูรณ์ (Complete cleft palate) พบรอยแยกทั้งเพดานแข็งและเพดานอ่อน



อ้างอิง : <http://minkkiieghj.blogspot.com/2014/>

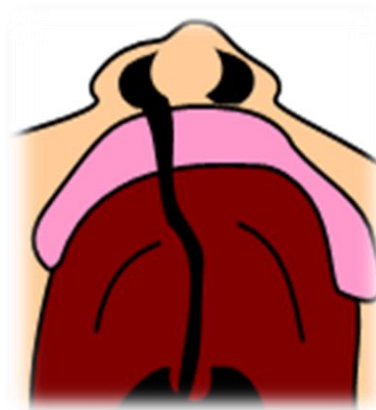
► 2. เพดานโหว่ชนิดไม่สมบูรณ์ (Incomplete cleft palate)
ปรากฏช่องโหว่บริเวณเพดานอ่อน



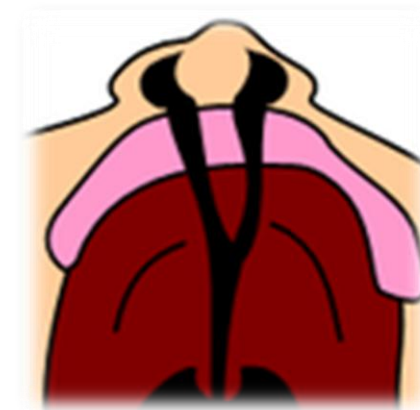
อ้างอิง : <http://minkkiieghj.blogspot.com/2014/>



เพดานโหว่ไม่สมบูรณ์
(Incomplete cleft palate)



ปากแหว่งเพดานโหว่
ข้างเดียวสมบูรณ์
(Unilateral complete
cleft lip & palate)



ปากแหว่งเพดานโหว่
สองข้างสมบูรณ์
(Bilateral complete cleft
lip & palate)

อ้างอิง : <http://minkkiieghj.blogspot.com/2014/>

สาเหตุ

ยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น

- ▶ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
- ▶ ช่วงตั้งครรภ์ มารดาขาดสารอาหาร ความเครียด การสูบบุหรี่ หรือดื่มสุราประจำ
- ▶ การได้รับพิษของยาหรือสารเคมีบางอย่าง
- ▶ การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิด เช่น หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
- ▶ ได้รับสารกัมมันตภาพรังสีขณะตั้งครรภ์

แนวทางการรักษา

วางแผนการรักษาร่วมกันเป็นทีมสหสาขา ได้แก่ กุมารแพทย์
ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์ด้านหู คอ จมูก นักแก้ไขการได้ยิน
และ นักแก้ไขการพูด

- ▶ ทันตแพทย์ – จัดฟัน ทำให้การพูดบางเสียงชัดขึ้น
- ▶ ศัลยแพทย์ – ผ่าตัดแก้ไข
- ▶ แพทย์ด้านหู คอ จมูก – คัดกรองการได้ยิน ป้องกันไม่ให้เกิด
หูชั้นกลางอักเสบหรือหูหนวกถาวร
- ▶ นักแก้ไขการพูด - แก้ไขการพูดที่ผิดปกติ

แผนการรักษาตามช่วงอายุ

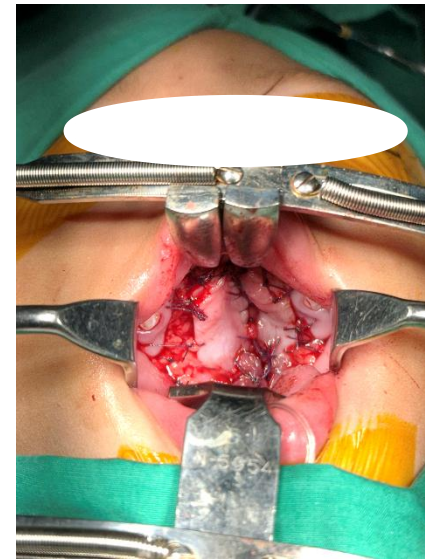
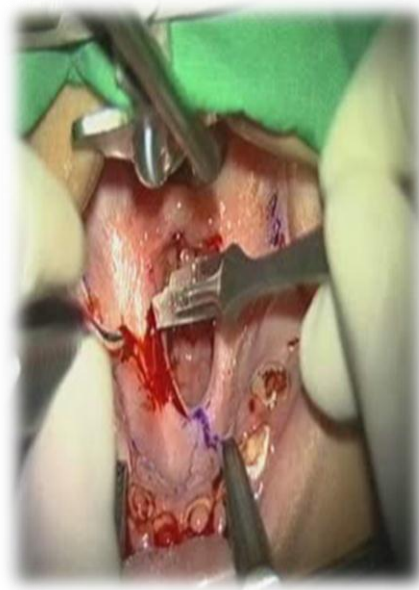
- ▶ แรกเกิด-3เดือน – ทันตแพทย์ ทำเพดานเทียม (obturator) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการดูดและการกลืน
- ▶ 3-5เดือน – ศัลยแพทย์ผ่าตัดแก้ไขรอยแยกบริเวณริมฝีปาก
- ▶ 12-18เดือน – ศัลยแพทย์ผ่าตัดแก้ไขรอยแยกบริเวณเพดานปาก
- ▶ 2-5ปี – นักฝึกพูดช่วยแก้ไขความผิดปกติของการออกเสียง
- ▶ 7-9ปี – ทันตแพทย์ จัดฟัน
- ▶ 9-12ปี – ศัลยแพทย์ผ่าตัดทำการผ่าตัดปลูกกระดูกบริเวณรอยแยกของกระดูกเบ้าฟัน เพื่อปิดรูทะลุระหว่างช่องปากและจมูกที่ยังเหลือจากการผ่าตัดปิดเพดานปาก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดรักษาภาวะเพดานโหว่

- ▶ ช่วงเวลาที่นิยมผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดานโหว่มากที่สุด คือ
เด็กมีอายุประมาณ $1^{1/2}$ -2 ปี (12-18 เดือน) → ก่อนเด็กเริ่มหัดพูด
เพื่อให้สามารถพูดได้เป็นปกติมากที่สุด

การผ่าตัด

การผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดานโหว่ (Palatoplasty) : เพื่อเย็บปิดช่องโหว่ของเพดานปาก



การดูแลก่อนผ่าตัด

- ▶ ทำความสะอาดร่างกายทั่วไป อาบน้ำ สระผม
- ▶ ระวัง!อย่าให้เด็กเป็นหวัดหรือมีไข้
(หากมีไข้ต้องเลื่อนการผ่าตัดไปจนกว่าจะหายดีก่อน)
- ▶ งดนม น้ำและอาหารทุกชนิด หลัง 3.00 น.

การดูแลระยะผ่าตัด

- ▶ การจัดทำสำหรับการผ่าตัด : จัดท่านอนหงายศีรษะแขงน เรียกว่า ท่า Rose position
- ▶ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ Donut jelly สำหรับหนุนศีรษะ , ผ้าสำหรับหนุนรองใต้ลำตัว, หมอน 2-3 ใบ (ขึ้นกับความยาวของลำตัว), chloramphenicol ointment สำหรับป้ายตา และ Ioban/tegaderm สำหรับปิดตา

อุปกรณ์จัดทำผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดานโหว่ (Cleft Palate)



การดูแลระยะผ่าตัด

► เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด ได้แก่

-เครื่องมือพื้นฐาน ได้แก่ Set Palate

-เครื่องมือพิเศษ ได้แก่ จี้หัวเข็ม, periosteums, mezenbaum

ยาวปลายแหลม

-วัสดุห้ามเลือด : spongostand

-เพิ่มเติม : rubber catheter No.10/12

ตัวอย่างโต๊ะเครื่องมือสำหรับส่งผ่าตัด



ภาพบรรยากาศ: Palatoplasty with Myringotomy



การดูแลระยะผ่าตัด

- ▶ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปห้องพักรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่
 - เตียงนอนชนิดยกที่กั้นขอบเตียงสูงทั้ง 2 ด้าน
 - หมอน 2 ใบ
 - ผ้าห่ม
 - ออกซิเจนชนิดพ่น (collugate)
 - ที่วัดออกซิเจนเด็ก

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังเสร็จผ่าตัดไปห้องพักฟื้น



การดูแลหลังผ่าตัด

- ▶ จัดให้นอนตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง
- ▶ ให้ออกซิเจน
- ▶ วัดสัญญาณชีพ
- ▶ เมื่อฟื้นและสามารถไอได้ ให้ลองจิบน้ำ โดยใช้ที่หยอดยาหยดเข้าปาก ถ้าไม่อาเจียนจึงให้นมได้ (ใช้ที่หยอดยาแทนการดูดนม)

การดูแลหลังผ่าตัด

- ▶ หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง ให้อาหารเหลวหรือซูปขึ้นๆที่ไม่ร้อน
- ▶ ให้ยาแก้ปวดใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด จากนั้นให้ทุก 4-6 ชั่วโมง
- ▶ เมื่อเด็กสามารถกินนม น้ำ และยาได้ ไม่มีผลแทรกซ้อนให้กลับบ้านได้

การดูแลที่บ้าน

► การให้อาหาร

- ควรให้อาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม ไข่ต้ม เนื้อปลานึ่ง เป็นต้น
- ห้าม ! ดื่มนมนาน 1 เดือนหลังผ่าตัด ให้ใช้ syring หรือที่หยอดยาป้อนนมแทน และป้อนน้ำตามทุกครั้ง เพื่อความสะอาดของแผล

การดูแลที่บ้าน

► ข้อควรระวัง!

- อย่าให้ผู้ป่วยดื่มนม, น้ำ, ลูกอม ในช่วง 1 เดือนแรกหลังผ่าตัด
- ห้ามอ้าปากเคี้ยวในแผล รวมทั้งการชวนเด็กพูดคุยเพราะ
ลิ้นอาจไปกระทบกระเทือนแผลผ่าตัด
- ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น อักเสบ แผลแยก ให้รีบพามา
พบแพทย์

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ที่อาจพบได้

- ▶ ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
- ▶ ภาวะเลือดออกมากหลังผ่าตัด
- ▶ ภาวะแผลแยก
- ▶ ภาวะแผลอักเสบ ติดเชื้อ

Critical points :

▶ Airway management : ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ

1. ขณะใส่ Dingman mouth gag มีจุดวิกฤตใดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ ?

Critical points :

► Airway management : ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ

1. ขณะใส่ Dingman mouth gag มีจุดวิกฤตใดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ

ตอบ

- ประเมินฟันและเนื้อเยื่อช่องปากของเด็กก่อนและหลังใส่ Dingman mouth gag เพื่อป้องกันฟันหักหรือหลุดลงไปในทางเดินหายใจ

(ควรสอบถาม ตรวจสอบตั้งแต่ก่อนพาเข้าห้องผ่าตัด ก่อนดมยาสลบ)

Critical points :

▶ Airway management : ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ

1. ขณะใส่ Dingman mouth gag มีจุดวิกฤตใดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ

ตอบ

- ตรวจสอบไม่ให้ Dingman mouth gag กดทับ

ท่อช่วยหายใจ

Critical points :

▶ Airway management : ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ

1. ขณะใส่ Dingman mouth gag มีจุดวิกฤตใดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ

ตอบ

- ดูแลทาสลีนให้ริมฝีปากชุ่มชื้น และไม่ให้เกิดการกดทับ
ริมฝีปากและมุมปากนานเกินไป เพื่อป้องกันเนื้อเยื่อขาดเลือด

Critical points :

- ▶ Airway management : ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
- ▶ ความเสี่ยงจากการจัดทำผ่าตัด

Critical points :

► ป้องกันอันตราย/ความเสี่ยงจากการจัดทำผ่าตัด

1. Palatoplasty -> ทำ Rose position

เสี่ยง : - แผลกดทับบริเวณท้ายทอย

ตอบ : Donut jel support

เสี่ยง : - การได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตา

ตอบ : ป้ายตาด้วย vidisic jel / chloramphenical eye ointment และ

ปิดตาด้วย ioban / tegaderm

Critical points :

- ▶ Airway management : ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ
- ▶ ความเสี่ยงจากการจัดทำผ่าตัด
- ▶ ภาวะเลือดออกมากหลังเสร็จผ่าตัด

Critical points :

▶ ภาวะเลือดออกมากหลังเสร็จผ่าตัด

1.บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดควรทำอย่างไร

ตอบ : circulating nurse

-> รีบเปิด suction ตัวที่ 2 ทันที และเตรียมไฟผ่าตัดให้พร้อม

-> ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกหมดมยาในการ re-intubate

Critical points :

▶ ภาวะเลือดออกมากหลังเสร็จผ่าตัด

1.บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดควรทำอย่างไร

ตอบ : scrub nurse

-> ตั้งสติ และเตรียม set palato จี้ไฟฟ้า suction ผ้าซับ โลหิต
วัสดุห้ามเลือด ให้พร้อม

-> เตรียมพร้อมจัดโต๊ะเครื่องมือสำหรับส่งผ่าตัดเพื่อ stop bleed

Critical points :

กรณีผู้ป่วยมีภาวะ airway obstruction ที่มีการ re-intubate วางแผนร่วมกันกับทีมศัลยแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ ว่าควรพิจารณาย้ายผู้ป่วยไปหอผู้ป่วยวิกฤติ (PICU) หรือไม่

-> ถ้าย้าย: - โทรประสานงาน ward เดิม และ PICU ให้ทราบ

- ประสานงานศูนย์เคลื่อนย้าย เพื่อขอเปล ออกซิเจน มอนิเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้าย

- ประสานทีมแพทย์ พยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้าย ให้พร้อม

สรุป

- ▶ ก่อนผ่าตัด : NPO ไข้? ฟันโยก?
- ▶ ระหว่างผ่าตัด : การป้องกันความเสี่ยงจากการจัดทำ
Rose position และความพร้อมใช้ของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
- ▶ หลังผ่าตัด : critical point และคำแนะนำการดูแลหลังผ่าตัด
แก้ญาติ เพื่อป้องกันแผลแยก

ข้อซักถาม

????



The End

Thank you for your attention

